

PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT DISA PRIMA PRIMA
RUMAH SAKIT DHARMA HUSADA PROBOLINGGO
DENGAN
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk (ASURANSI MAG)
TENTANG
FASILITAS RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN
BAGI PESERTA PROGRAM KESEHATAN

Nomor : _____ (diisi oleh RS)

Nomor : PKS-_____/_____/2025/MAG-(N/R)

Pada hari ini Jumat, tanggal **Satu** bulan **Mei** tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, **(01/05/2026)** yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE** sebagai Direktur **PT. DISA PRIMA PRIMA** didirikan berdasarkan Akta nomor 14, tanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima), dibuat dihadapan Rita Sutandio, S.H, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Probolinggo, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor AHU-0039865.AH.01.01. Tahun 2025 tertanggal 19 (Sembilan Belas) 05 (Mei) 2025 (Dua Ribu Dua Puluh Lima) selaku Badan Usaha pengelola Rumah Sakit:
 - A. **Rumah Sakit Dharma Husada Probolinggo** dengan izin operasional Rumah Sakit Nomor Induk Berusaha 0206250019619 tertanggal 17 Maret 2026 diwakili oleh dr. Ifit Bagus Apriantono, M.MRS sebagai Direktur Rumah Sakit Dharma Husada yang beralamat di Jl. Panjaitan No. 8 - 10 Kota Probolinggo yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **Pihak Pertama**.
 - B. **PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk (ASURANSI MAG)**, berkantor pusat di The City Center Batavia Tower One, Lt. 17 Jl. KH Mas Mansyur Kav.126, Jakarta Pusat 10220, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 87 tanggal 14 November 1980 yang dibuat dan dihadapan Haji Bebas Daeng Lalo, SH notaris di Jakarta dan telah mendapat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor Y.A. 5/28/5 tanggal 29 Januari 1981 dan Perubahan Anggaran Dasar terakhir No. 93 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.03-0090303 tanggal 12 Juli 2023. Dalam hal ini diwakili oleh **Muhammad Reza Putra S. IP** yang bertindak dalam jabatannya selaku **Kepala Divisi Asuransi Kesehatan/GHS** berdasarkan Surat Kuasa Nomor 200/HRD-MY/08/2019 yang ditandatangani oleh Direksi pada tanggal 1 Agustus 2019, dari dan oleh karena itu bertindak secara sah untuk dan atas nama PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk, selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut **Pihak Kedua**.

Dalam hal **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** disebutkan secara bersama-sama dalam Perjanjian maka disebut Para Pihak.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Pihak Pertama** adalah rumah sakit yang memberikan pelayanan kesehatan baik rawat inap maupun rawat jalan.

2. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang usaha asuransi umum yang memiliki produk-produk asuransi diantaranya asuransi kesehatan yaitu **Magna Sehat**.
3. Bahwa **Pihak Kedua** bermaksud menggunakan pelayanan kesehatan **Pihak Pertama** berupa fasilitas rawat inap dan rawat jalan bagi Tertanggung **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut Peserta).
4. **Pihak Pertama** bersedia menyediakan pelayanan kesehatan berupa fasilitas rawat inap dan rawat jalan kepada Tertanggung **Pihak Kedua**.

Berdasarkan hal-hal yang disebutkan di atas, maka Para Pihak secara sah dan sepakat membuat Perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 PENGERTIAN ISTILAH

1. **Peserta Program Kesehatan**, ialah setiap karyawan dan anggota keluarganya yang dijamin oleh **Pihak Kedua** dan yang memiliki Kartu Peserta yang masih berlaku.
2. **Kartu Peserta**, ialah kartu yang diterbitkan **Pihak Kedua** yang memuat identitas peserta program kesehatan.
3. **Laporan Medis Awal (LMA)**, ialah surat konfirmasi medis awal yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** dan wajib diisi oleh **Pihak Pertama** untuk mengetahui pemberian keputusan awal pada saat pertama peserta mendapatkan pelayanan Kesehatan dari **Pihak Pertama**.
4. **Konsul Medis Lanjutan**, ialah surat yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** dan diisi oleh **Pihak Pertama** apabila informasi yang disampaikan dalam Laporan Medis Awal yang diisi oleh **Pihak Pertama** belum jelas dan lengkap.
5. **Surat Pengantar Rawat**, ialah surat jaminan yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua**, yang menyatakan bahwa **Pihak Kedua** akan menanggung biaya pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh **Pihak Pertama**. Surat jaminan ini wajib diserahkan kepada **Pihak Pertama** sekurang-kurangnya dalam waktu 2 X 24 jam hari kerja, sejak Peserta Program Kesehatan menerima Pelayanan Kesehatan.
6. **Formulir Klaim Rawat Inap**, ialah formulir yang diterbitkan oleh **Pihak Kedua** yang berisi Laporan Medis singkat dari peserta yang dirawat yang wajib diisi oleh dokter yang merawat dengan lengkap dan sebenar-benarnya. Laporan Medis yang dikirimkan oleh **Pihak Pertama** tidak dapat diubah untuk kepentingan salah satu pihak.
7. **Kartu Berobat**, ialah kartu yang dikeluarkan oleh **Pihak Pertama** yang berisi data pasien dan nomor medical record dan untuk pembuatannya tidak dikenakan biaya kartu.
8. **Rawat Inap**, ialah perawatan bagi peserta program kesehatan yang memerlukan suatu tindakan medis dan penunjang medis atau karena keadaan kesehatannya, memerlukan pengawasan dan perawatan secara terus menerus dari seorang dokter untuk kesembuhannya, sehingga memerlukan tinggal sementara di Rumah Sakit.
9. **Rawat Jalan**, ialah konsultasi, pemeriksaan dan pengobatan serta perlakuan suatu tindakan medis dan penunjang medis yang dibutuhkan bagi peserta program kesehatan, tanpa memerlukan pengawasan dan perawatan secara terus menerus yang memerlukan tinggal sementara di Rumah Sakit.
10. **ODS (One Day Surgery)**, ialah tindakan medis yang diberikan **Pihak Pertama** guna memulihkan kesehatan dan atau keadaan tertentu dari peserta **Pihak Kedua** yang membutuhkan tindakan pembedahan ringan atau sedang yang tidak memerlukan perawatan inap.
11. **Tindakan Medis**, ialah semua tindakan yang diperlukan dan sesuai indikasi medis guna pemeliharaan kesehatan peserta.
12. **Penunjang Medis**, ialah semua jenis pemeriksaan dan pemberian obat-obatan yang diperlukan dan sesuai indikasi medis guna pemeliharaan kesehatan peserta.
13. **Pasien Umum**, ialah dimana peserta karena tidak mengikuti peraturan yang berlaku telah kehilangan haknya mengikuti fasilitas ini, sehingga peserta tersebut diperlakukan seperti pasien-pasien lain pada umumnya dimana peserta tersebut harus menyelesaikan terlebih dahulu semua biaya yang terjadi.
14. **Layanan TPA Full Payor**, ialah jasa pengelolaan penjaminan dan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan peserta **Pihak Kedua** oleh Pihak yang telah ditunjuk **Pihak Kedua**.

15. **Layanan TPA Technology Only**, ialah jasa pelayanan administrasi kesehatan dengan menggunakan sistem oleh Pihak yang telah ditunjuk **Pihak Kedua** untuk memeriksa keabsahan dan memasukkan data secara elektronik.
16. **Hari Kerja**, ialah hari pelayanan operasional dari Senin sampai dengan Jumat pukul 08.00 - 17.00 WIB, tidak termasuk hari Libur Nasional dan atau Cuti Bersama.
17. **Perjanjian** ialah perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian ini termasuk tetapi tidak terbatas pada addendum, perubahan, dan lampirannya.

PASAL 2 PRINSIP KERJA SAMA

Pihak Pertama ditunjuk dan setuju menyediakan fasilitas Rawat Inap dan Rawat Jalan bagi para peserta Program Kesehatan yang diselenggarakan oleh **Pihak Kedua**.

PASAL 3 RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

1. Ruang Lingkup Pelayanan
 - 1.1. Ruang Lingkup Rawat Inap, yang terdiri dari:
 - 1.1.1. Rawat Inap dikelas sesuai dengan hak Peserta yang tercantum pada Kartu Peserta.
 - 1.1.2. Perawatan oleh dokter umum atau spesialis, jika dibutuhkan.
 - 1.1.3. Sarana penunjang Diagnostik yang sesuai dengan indikasi medis dan standard prosedur medis yang berlaku.
 - 1.1.4. Tindakan dengan alat-alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan medis.
 - 1.1.5. Obat-obatan yang tetap berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau Daftar Obat Generik atau obat lainnya jika dibutuhkan atau tidak tersedianya bentuk Generik.
 - 1.2. Ruang Lingkup Rawat Jalan, yang terdiri dari:
 - 1.2.1. Konsultasi/Tindakan Dokter Umum atau Dokter Spesialis.
 - 1.2.2. Sarana penunjang Diagnostik yang sesuai dengan indikasi medis dan standard prosedur medis yang berlaku.
 - 1.2.3. Tindakan dengan alat-alat kedokteran sesuai dengan kebutuhan medis.
 - 1.2.4. Obat-obatan yang tetap berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) atau Daftar Obat Generik atau obat lainnya jika dibutuhkan atau tidak tersedia dalam bentuk Generik dan telah terdaftar pada Dirjen POM Indonesia.
 - 1.3. Ruang Lingkup *One Day Surgery* (ODS), yang terdiri dari:
 - 1.3.1. Adanya tindakan pembedahan berupa sayatan yang meliputi semua jasa bedah, jasa dokter, dan pemberian obat-obatan, alat bantu bedah dan jasa penunjang lainnya.
 - 1.3.2. Pemberian tindakan pembedahan dapat selesai hanya dalam 1 (satu) hari sesuai anjuran dokter, dengan tanpa dikenakan biaya kamar perawatan.
2. Prosedur Pelayanan Kesehatan
 - 2.1. Prosedur Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Inap:
 - 2.1.1. Peserta datang dengan menunjukkan Kartu Peserta yang masih berlaku serta Surat Pengantar Rawat yang dikeluarkan oleh **Pihak Kedua** dan Surat Rujukan dari dokter umum atau spesialis. Bilamana ada peserta yang datang dalam keadaan darurat tanpa membawa Kartu Peserta atau Surat Pengantar Rawat, maka **Pihak Pertama** diminta segera melakukan konfirmasi kepada **Pihak Kedua** berkaitan dengan status kepesertaan yang bersangkutan dan meminta Surat Pengantar Rawat untuk perawatan lebih lanjut dari yang bersangkutan.
 - 2.1.2. **Pihak Pertama** dalam melaksanakan pelayanan Kesehatan kepada Peserta Program Kesehatan wajib untuk memberikan konfirmasi kepada **Pihak Kedua** antara lain dalam hal:
 - a) Konfirmasi awal, dilakukan paling lambat dalam waktu 1 x 24 jam apabila ada Peserta Program Kesehatan yang memperoleh fasilitas Rawat Inap.

- b) Melakukan pengisian dan mengirimkan Laporan Medis Awal beserta dengan Hasil Pemeriksaan Penunjang paling lambat 1 x 24 jam sejak konfirmasi awal dilakukan.
 - c) Melakukan pengisian dan mengirimkan kembali Konsul Medis Lanjutan (apabila diperlukan) paling lambat 1 x 24 jam sejak Konsul Medis Lanjutan diterima.
 - d) Indikasi Medis atau dokter tidak serta merta dapat dilaksanakan penjaminannya oleh **Pihak Pertama** tanpa persetujuan **Pihak Kedua**.
 - e) Berkaitan dengan Poin C & D **Pihak Pertama** harus mengisi kembali Form Konsul Medis Lanjutan dan harus menjelaskan kepada Peserta **Pihak Kedua** tentang batas penjaminan yang diberikan **Pihak Kedua**
 - f) Konfirmasi selama perawatan, meliputi konfirmasi tindakan, pemeriksaan penunjang dan obat-obatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g) **Pihak Pertama** harus memberikan informasi kepada **Pihak Kedua** alasan yang sebenarnya perihal lama perawatan, masuk rumah sakit di hari Sabtu dan Minggu dengan kategori nyata observasi.
 - h) Konfirmasi akhir, pada saat perawatan Peserta Program Kesehatan berakhir.
- 2.1.3. Jika peserta dirawat pada hari libur, **Pihak Pertama** akan melaporkan melalui *Call Center Pihak Kedua* atau pada hari kerja berikutnya.
- 2.1.4. **Pihak Pertama** membebaskan peserta dari kewajiban pembayaran uang muka yang timbul dari Pelayanan Kesehatan yang diberikan, sepanjang tidak bertentangan dengan Perjanjian ini.
- 2.1.5. Perawatan kategori pre-pembedahan (observasi) yang berindikasi kuat dapat dijamin **Pihak Kedua** dalam 1 (satu) tagihan di hari yang sama dengan Tindakannya. Apabila tetap dilakukan (menginap) tanpa adanya indikasi yang kuat dan persetujuan **Pihak Kedua**, maka segala biaya dan pelayanan yang timbul akan dibebankan kepada **Pihak Pertama**.
- 2.1.6. Apabila peserta, atas keinginannya sendiri mengambil kamar yang lebih tinggi dari haknya, maka fasilitas ini juga otomatis akan gugur dan peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum dimana seluruh biaya yang timbul sejak awal perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan pasien.
- 2.1.7. Apabila kamar yang menjadi hak peserta penuh dan atau karena keadaan penyakitnya, maka peserta yang bersangkutan akan ditempatkan sementara di kamar yang lebih rendah / tinggi dan fasilitas ini dapat terus berjalan dengan catatan ketika kamar yang menjadi haknya tersedia peserta wajib kembali atau dipindahkan ke kamar yang sesuai dengan haknya. Jika peserta tidak bersedia maka peserta tersebut akan diperlakukan sebagai pasien umum dimana seluruh biaya yang timbul sejak awal perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan pasien.
- 2.1.8. Untuk pemeriksaan / pemberian obat-obatan / tindakan yang harganya di atas Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per-item, **Pihak Pertama** melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua** mengenai pertanggungannya.
- 2.1.9. Untuk pemeriksaan / Tindakan medis di luar kondisi CITO yang dilakukan **Pihak Pertama** tanpa persetujuan **Pihak Kedua** / dilakukan dengan persetujuan peserta dan atau keluarga saja maka penjaminannya akan dibebankan kepada **Pihak Pertama**
- 2.2.0. **Pihak Kedua** berhak menolak permintaan penjaminan Rawat Inap apabila tidak ditemukan indikasi yang kuat untuk di Rawat Inap kecuali Emergency (Cito/life-saving)
- 2.2.1. Dalam setiap pelayanan, daftar penyakit / tindakan yang tidak bisa ditanggung akan menjadi tanggung jawab peserta di Rumah Sakit dan tidak bisa ditagihkan kecuali sudah ada permintaan dari **Pihak Kedua** untuk langsung menagihkan seluruh biaya ke **Pihak Kedua**.

Seperti disebutkan dibawah ini daftar Penyakit / Tindakan / Perawatan / Kondisi yang tidak bisa ditanggung oleh **Pihak Kedua**:

- a) Perawatan Inap yang tidak diperlukan / tidak berindikasi medis.
- b) Rawat Inap yang semata-mata ditujukan hanya untuk melakukan pemeriksaan Laboratorium / Pemeriksaan penunjang termasuk untuk *check up* atau perawatan

inap untuk melakukan *Physiotherapy* saja.

- c) Tindakan / Pemeriksaan yang bersifat *screening* dan tidak mutlak diperlukan dalam terapi.
- d) Tindakan pemeriksaan dan atau terapi / obat-obatan yang tidak berindikasi medis.
- e) Terapi / obat-obatan yang diberikan pada saat pasien pulang dalam jumlah yang berlebihan (tidak lebih dari 7 (tujuh) hari dari saat pasien keluar Rumah Sakit).
- f) Tindakan / Perawatan yang tidak dikonfirmasi terlebih dahulu, perawatan yang tidak memiliki Surat Pengantar Rawat atau kartu telah '*expired*' atau tidak berlaku lagi.
- g) Segala sesuatu yang diminta oleh pasien namun tidak berhubungan dengan terapi atau segala sesuatu yang bersifat personal misalnya makanan tambahan, telpon, koran, *tissue*, perlengkapan mandi, *laundry*, dsb.

2.2. Prosedur Pelayanan Kesehatan untuk Rawat Jalan:

- 2.2.1. Peserta wajib menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku dan kartu Identitas (KTP/Passport), apabila peserta tidak dapat menunjukkan kartu peserta maka peserta akan diberlakukan sebagai Pasien Umum dimana seluruh biaya yang timbul sejak awal perawatan sepenuhnya menjadi tanggungan pasien.
- 2.2.2. **Pihak Pertama** membebaskan peserta dari kewajiban pembayaran uang muka.
- 2.2.3. Untuk segala pemeriksaan Penunjang Fisioterapi dan Laboratorium termasuk pembelian obat-obatan, Peserta wajib membawa rujukan/resep yang diberikan oleh Dokter **Pihak Pertama** terlebih dahulu
- 2.2.4. **Pihak Pertama** diminta untuk memperhatikan batas penjaminan seperti yang tercantum di belakang kartu peserta atau struk pengesahan awal pada sistem.
- 2.2.5. Apabila biaya yang terjadi melebihi Faedah yang tercantum di dalam kartu atau struk pengesahan akhir pada sistem, maka kelebihan biaya tersebut wajib diselesaikan oleh peserta sebelum meninggalkan tempat.
- 2.2.6. Untuk pemeriksaan / pemberian obat-obatan yang harganya di atas Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah) per item **Pihak Pertama** melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua** mengenai pertanggungannya.
- 2.2.7. Apabila **Pihak Pertama** tidak melakukan konfirmasi kepada **Pihak Kedua** seperti tersebut di Ayat 2.2.6 maka jika ada penyakit / tindakan / obat / pemeriksaan penunjang yang tidak bisa ditanggung maka **Pihak Kedua** tidak akan membayarkannya kepada **Pihak Pertama** dan **Pihak Pertama** akan langsung menagihkannya kepada Peserta **Pihak Kedua**
- 2.2.8. Dalam setiap pelayanan, daftar penyakit / tindakan yang tidak bisa ditanggung akan menjadi tanggung jawab peserta di tempat dan tidak bisa ditagihkan kecuali sudah ada permintaan dari **Pihak Kedua** untuk langsung menagihkan seluruh biaya ke **Pihak Kedua**.
Seperti disebutkan di bawah ini daftar Penyakit/Tindakan/Perawatan/Kondisi yang tidak bisa ditanggung:
 - a) Tindakan pemeriksaan dengan menunjukkan Kartu telah '*expired*'
 - b) Tindakan / Perawatan yang tidak diperlukan/tidak berindikasi medis, tidak sesuai dengan diagnosa penyakit, yang bersifat *screening* dan yang tidak mutlak diperlukan dalam terapi.
 - c) Terapi/obat-obatan yang tidak berindikasi medis; termasuk segala jenis vitamin, supplement, obat penenang, dan obat hormonal baik dengan maupun tanpa rekomendasi dokter untuk konsultasi rawat jalan.
 - d) Pemeriksaan Penunjang / Pembelian Obat-obatan tanpa melalui pemeriksaan Dokter dari Rumah Sakit **Pihak Pertama** atau atas permintaan sendiri.
 - e) Peresepan obat-obatan yang dapat dibeli secara bebas (OTC - *on the Counter*), yaitu obat-obatan golongan bebas dan bebas terbatas seperti minyak telon, balsem, betadin, dsb, serta obat herbal seperti diapet, kiranti, dsb, baik dengan maupun tanpa rekomendasi dokter.

- f) Biaya Non Medis seperti biaya Kartu Berobat, Buku Panduan Kesehatan, *masker*, *underpad*, biaya fotokopi dan materai.
- g) Perawatan yang bertujuan untuk estetika dan atau kosmetik.
- h) Perawatan untuk mengatasi kegemukan, penurunan berat badan atau penyesuaian berat badan.
- i) Penggunaan segala jenis alat bantu seperti alat bantu dengar, korset, dsb.
- j) Segala sesuatu yang diminta oleh pasien namun tidak berhubungan dengan terapi atau segala sesuatu yang bersifat personal seperti *tissue*, termometer, pasta gigi, biaya makanan tambahan (termasuk susu dan bubur bayi), dsb.
- k) Pemberian obat yang berlebihan baik dari sisi kegunaan maupun dari indikasinya.
- l) Tindakan pencegahan termasuk segala bentuk imunisasi, vaksinasi, KB, dan kontrol hamil.
- m) Biaya cek rutin kesehatan (*medical chek-up*).

2.3. Prosedur Pelayanan Kesehatan untuk ODS (*One Day Surgery*):

- 2.3.1. Peserta wajib menunjukkan kartu peserta yang masih berlaku dan melampirkan Surat Pengantar Rawat kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian ini.
- 2.3.2. **Pihak Pertama** diminta segera melakukan konfirmasi kepada **Pihak Kedua** berkaitan dengan status kepesertaan yang bersangkutan dan informasi biaya tindakan *one day surgery*.
- 2.3.3. **Pihak Pertama** diminta untuk melakukan konfirmasi pada saat Peserta pulang dengan menginformasikan total biaya perawatan yang terjadi.

PASAL 4 BIAYA PELAYANAN

- 1. Biaya pelayanan kesehatan Peserta sesuai dengan kelas dan jaminannya menjadi tanggungan **Pihak Kedua**.
- 2. Tagihan dikirimkan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** segera setelah berakhirnya masa perawatan (sekurang-kurangnya 30 (Tiga puluh) hari kalender setelah perawatan) sesuai dengan biaya tarif yang berlaku di Rumah Sakit **Pihak Pertama**.
- 3. Bilamana tagihan tidak diterima sampai dengan tenggang waktu yang sudah ditentukan diatas, maka tagihan tersebut sudah tidak menjadi tanggung jawab **Pihak Kedua**. **Pihak Pertama** selanjutnya tidak dapat melakukan tagihan secara langsung kepada Peserta atas klaim yang tidak dapat dibayarkan **Pihak Kedua** tersebut.
- 4. **Pihak Kedua** setuju untuk menyelesaikan pembayaran atas tagihan tersebut sekurang – kurangnya 30 (Tiga puluh) hari kerja setelah seluruh dokumen penagihan diterima secara lengkap oleh **Pihak Kedua**.
- 5. Tagihan **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua** dilengkapi dengan dokumen-dokumen penagihan sebagai berikut:
 - a. Rawat Inap:
 - 1. Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan alamat transfer (Nama Bank, Nomor Rekening Bank), sebagaimana tercantum dalam pasal ini.
 - 2. Kuitansi asli yang dibubuhi materai secukupnya
 - 3. Surat Pengantar Berobat dan resume medis **Pihak Pertama**.
 - 4. Surat Pengantar Rawat (SPR) dari **Pihak Kedua**.
 - 5. Perincian Penagihan dan melampirkan copy kuitansi DP (*Down Payment*) atau kuitansi pembayaran dari peserta atas selisih biaya perawatan di tempat.
 - 6. Rekapitulasi/Faktur Penagihan Rumah Sakit **Pihak Pertama** dengan memisahkan antara biaya konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
 - b. Rawat Jalan:
 - 1. Surat Permintaan Pembayaran dengan mencantumkan alamat transfer (Nama Bank, Nomor Rekening Bank), sebagaimana tercantum dalam pasal ini.
 - 2. Kuitansi asli yang dibubuhi materai secukupnya lengkap dengan perincian biaya dan copy

- resep/copy hasil pemeriksaan yang dilakukan.
3. Struk Pengesahan (awal& akhir) pada sistem.
 4. Rekapitulasi/Faktur Penagihan Rumah Sakit **Pihak Pertama** dengan memisahkan antara biaya konsultasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
6. Pembayaran tersebut akan dilakukan oleh **Pihak Kedua** dengan cara transfer, pemindahbukuan ke rekening Bank **Pihak Pertama** melalui rekening sebagai berikut:
- | | |
|----------------------------|---|
| NAMA BANK | : PT BANK RAKYAT INDONESIA, Tbk |
| CABANG | : MALANG SUTOYO |
| ALAMAT LENGKAP BANK | : JL. LETJEN SUTOYO NO. 105 MALANG |
| NO. REKENING | : 042901001441306 |
| A.N. | : PT DISA PRIMA PRIMA |
| KODE SWIFT/IBAN | : BRINIDJA |
- dan biaya yang terjadi atas pemindah bukuan tersebut menjadi tanggungan **Pihak Pertama**.
7. Dalam hal penagihan, **Pihak Pertama** wajib untuk meminta nama jelas dan tanda tangan pasien/keluarga pasien untuk menandatangani (bukan paraf) perincian kuitansi yang akan dikirimkan ke **Pihak Kedua**, sehingga kuitansi tersebut dianggap telah diketahui oleh keluarga pasien.
 8. Rekonsiliasi tagihan **Pihak Pertama** akan dilakukan 4 (empat) periode dalam setahun yaitu :
 - b. Pada akhir bulan April untuk periode Januari hingga Maret;
 - c. Pada akhir bulan Juli untuk periode April hingga Juni;
 - d. Pada akhir bulan Oktober untuk periode Juli hingga September; dan
 - e. Pada akhir bulan Januari untuk periode Oktober hingga Desember.Adapun jika sudah melewati batas waktu yang dimaksud tagihan tersebut tidak diinformasikan oleh **Pihak Pertama**, maka tagihan tersebut tidak dapat diajukan kembali ke **Pihak Kedua**.
 9. Peserta yang pembayarannya dijamin oleh **Pihak Kedua**, maka permintaan copy/legalisir kwitansi dan atau Resume Medis tidak dapat dilakukan melalui **Pihak Pertama**. Peserta **Pihak Kedua** dipersilahkan untuk berhubungan langsung dengan **Pihak Kedua** mengingat dokumen asli telah diberikan oleh **Pihak Pertama** kepada **Pihak Kedua**.
 10. **Pihak Pertama** menyetujui untuk setiap total tagihan biaya pelayanan kesehatan Peserta **Pihak Kedua** dikenakan Biaya Administrasi:
 - a) Rawat Inap Rp.....
 - b) Rawat Jalan Rp.....
 11. **Pihak Pertama** setuju dan sepakat untuk memberikan potongan harga atau discount atas setiap biaya Pelayanan Kesehatan Rawat Inap dan Rawat Jalan kepada **Pihak Kedua** sebesar **2 % (Dua persen)** dari total tagihan yang diajukan oleh **Pihak Pertama** berdasarkan tarif yang berlaku dan telah disepakati kedua belah pihak.

PASAL 5 PENGGOLONGAN KELAS DAN TARIF RUMAH SAKIT

1. Dalam hal terjadinya kenaikan atau penurunan tarif Rumah Sakit, maka **Pihak Pertama** wajib memberitahukan kepada **Pihak Kedua** tentang perubahan buku tarif tersebut, sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tarif tersebut berlaku.
2. Perubahan tarif tersebut apabila disetujui oleh **Pihak Kedua** hanya akan berlaku bagi peserta yang masuk Rumah Sakit setelah tanggal berlakunya tarif.
3. Bagi peserta yang sedang dalam perawatan, maka tarif baru akan diberlakukan segera setelah berlakunya tarif tersebut.
4. **Pihak Pertama** menjamin bahwa tarif dan biaya – biaya yang dibebankan kepada **Pihak Kedua** adalah sesuai dengan standar umum yang berlaku juga bagi Pasien Umum di Rumah Sakit **Pihak Pertama**.
5. Penggolongan kelas perawatan bagi para peserta program kesehatan sesuai dan telah diatur pada pasal 3 ayat 2.1.5 dan seterusnya.
6. **Pihak Pertama** menjamin dalam setiap tindakan medis khususnya pembedahan jasa dokter sudah masuk ke dalam buku tarif tersebut

7. **Pihak Kedua** tidak akan menjamin perawatan dengan DPJP yang tarifnya tidak mengikuti ketentuan yang berlaku di RS dan tertera dalam Buku Tarif

PASAL 6

PENGUNAAN LAYANAN TPA

1. **Pihak Kedua** akan memberikan pemberitahuan melalui email kepada **Pihak Pertama** jika ada TPA *Full Payor* yang ditunjuk **Pihak Kedua** untuk mengelola penjaminan dan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Perusahaan Peserta **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** akan langsung melakukan koordinasi perihal penjaminan dan pembayaran tagihan pelayanan kesehatan Perusahaan Peserta **Pihak Kedua** dengan TPA *Full Payor* yang telah ditunjuk **Pihak Kedua**.
3. **Pihak Pertama** tetap melakukan koordinasi dengan **Pihak Kedua** terkait Penjaminan dan Pembayaran Tagihan untuk Pelayanan Kesehatan Peserta **Pihak Kedua** yang mempergunakan TPA *Technology Only*.

PASAL 7

PROGRAM JAGA MUTU DAN PENANGANAN KELUHAN

1. **Pihak Pertama** setuju bahwa **Pihak Kedua** akan mengadakan Program Jaga Mutu Eksternal:
 - 1.1. **Pihak Kedua** akan melakukan proses pemantauan pemanfaatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta oleh **Pihak Pertama**, evaluasi akan disampaikan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan sekali kepada **Pihak Pertama**.
 - 1.2. **Pihak Pertama** merekam seluruh kegiatan pelayanan kesehatan kepada peserta dan **Pihak Kedua** berhak untuk mendapatkan semua keterangan yang terdapat dalam Rekam medik termasuk Laporan Hasil Operasi bilamana diperlukan. Dalam hal ini **Pihak Kedua** memerlukan Laporan Medis termasuk Laporan Hasil Operasi dari **Pihak Pertama**, **Pihak Kedua** menjamin bahwa telah memiliki otorisasi penuh dari peserta **Pihak Kedua** untuk memperoleh Laporan Medis dan Informasi Medis lainnya dari **Pihak Pertama**. **Pihak Pertama** tidak akan bertanggung jawab terhadap segala resiko yang timbul dari penyerahan Laporan Medis tersebut kepada **Pihak Kedua**.
2. **Pihak Pertama** setuju untuk melakukan Program Jaga Mutu Internal Rumah Sakit guna tercapainya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi para peserta.
3. **Pihak Pertama** akan memberikan informasi yang jujur dan berimbang kepada Peserta **Pihak Kedua** perihal penjaminan perawatan.
4. **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** sepakat akan berkomunikasi dengan baik dalam penanganan pasien sejak awal masuk rumah sakit sampai dengan perawatan selesai sesuai limit penjaminan dari **Pihak Kedua**, termasuk riwayat perawatan sebelumnya dengan penjamin yang lain.

PASAL 8

KODE ETIK PROMOSI PEMASARAN

Pihak Pertama wajib membuat pemberitahuan kepada **Pihak Kedua** terakait dengan segala materi promosi pemasaran **Pihak Pertama** yang menyebutkan identitas **Pihak Kedua** seperti Nama dan Logo termasuk penggunaan kalimat Perusahaan Asuransi

PASAL 9

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sampai dengan jangka waktu 2 (dua) tahun, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2026 sampai dengan 1 Mei 2028, kecuali salah satu Pihak melakukan pemberitahuan secara tertulis untuk mengakhiri

Perjanjian ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir atas kesepakatan kedua belah Pihak.

PASAL 10

TINDAKAN KECURANGAN (*FRAUD*)

1. Para Pihak sepakat untuk memerangi segala bentuk tindakan kecurangan (*Fraud*) yang terjadi dari waktu ke waktu, oleh karenanya pencegahan dan pemberantasan *Fraud* sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan komitmen dan tanggung jawab para Pihak;
2. Sehubungan dengan komitmen tersebut pada ayat 1 di atas, **Pihak Pertama** setuju untuk membantu **Pihak Kedua** untuk memerangi *Fraud*, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan pemalsuan kwitansi pengibatan dan rincian pengobatan di rumah sakit;
3. **Pihak Kedua** berhak untuk meminta **Pihak Pertama** membuka historical transaksi biaya pengobatan pasien yang dirawat di Rumah Sakit **Pihak Pertama** yang diduga melakukan tindakan *fraud* yang berkaitan dengan pemalsuan kwitansi untuk klaim asuransi **Pihak Kedua**;
4. **Pihak Pertama** wajib menerbitkan surat keterangan tambahan kepada **Pihak Kedua** apabila diperlukan sehubungan dengan proses investigasi asuransi dan pembuktian yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** terhadap adanya dugaan *Fraud* dimaksud.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila timbul persengketaan atau perselisihan antara **Pihak Pertama** dengan **Pihak Kedua** sebagai akibat pelaksanaan dan/atau penafsiran Perjanjian ini, maka Para Pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dengan itikad baik.
2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah tersebut tidak menghasilkan kata sepakat dan/atau mencapai mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadinya perselisihan, maka Para Pihak sepakat untuk memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

PASAL 12

PEMBERITAHUAN DAN PARA WAKIL

1. Seluruh surat menyurat, korespondensi dianggap sah apabila diterima oleh Para Pihak pada alamat sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : PT DISA PRIMA PRIMA – RS DHARMA HUSADA PROBOLINGGO

Alamat : Jl. Panjaitan No. 8 – 10 Sukabumi, Mayangan, Kota Probolinggo
No. Telp. : (0335) 422176
Email : rsdharmahusadaprob@gmail.com

Untuk Perhatian	Marketing	Nama	: Murtias Puji Astutik, S.A.P
		Email	: humas.rsdhprobolinggo@gmail.com
		HP	: (+62) 851-3851-4521
	Keuangan	Nama	: Sindy Novenia, S.Pd, M.Ak
		Email	: keuangandpm165@gmail.com
		HP	: (+62) 812- 2442-9139
	Pengaduan	Nama	: Angela Wensi Flora R, S.Kep, Ns
		Email	: rsdharmahusadaprob@gmail.com
		HP	: (+62) 813-3074-1495

Admin Jaminan : Nama : Uswatun Hasanah, A.Md.Aktr
Email : admpenjaminrsdhprob@gmail.com
HP : (+62) 851-8830-3240

PIHAK KEDUA : PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk
Alamat : Komp. Permata Senayan Blok E No. 59-60 Jl. Tentara Pelajar
Kebayoran Lama, Jakarta Selatan - DKI Jakarta 12210
No. Telp : 150180
No. Fax. : (+6221) 57944226

Untuk Perhatian :

1. Head of Group Hospital & Surgical Claim Department : dr. Dian Paramita Kusumawardani
 2. Head of Provider Relation Section : Ewin Primanto (ewin@mag.co.id)
 3. Provider Relation : Ika Wulandari (provider@mag.co.id)
 4. **Call Centre/Hotline 24 Jam** : No. Telp : 150180
Email : hotline@mag.co.id
2. Apabila terjadi perubahan alamat, maka pihak yang merubah alamat wajib untuk memberitahukan kepada pihak lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum alamat baru berlaku secara efektif.

PASAL 13 PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian ini akan berakhir apabila Para Pihak sepakat untuk tidak memperpanjang Perjanjian ini.
2. Perjanjian dapat diakhiri sewaktu-waktu secara tertulis oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran Perjanjian dilaksanakan.
3. Pengakhiran Perjanjian tersebut tidak mengurangi hak dan kewajiban Para Pihak yang masih terkait terhadap Pertanggungan yang sedang berjalan baik kepada Para Pihak maupun Peserta Program Kesehatan.
4. Dalam hal Perjanjian ini diakhiri dan/atau dibatalkan oleh Para Pihak, maka Para Pihak dengan tegas melepaskan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sehingga untuk pengakhiran/pembatalan Perjanjian ini tidak diperlukan suatu Putusan Hakim.

PASAL 14 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. keadaan memaksa (Force Majeure) berdasarkan Perjanjian ini, termasuk tetapi tidak terbatas antara lain: segala bentuk bencana alam maupun bencana non alam, seperti bencana gempa bumi, banjir, angin topan, kebakaran, perang, huru hara dan gangguan-gangguan lain, akan tetapi dengan pengecualian atas pajak-pajak baru dan kepailitan atas para pihak berdasarkan perjanjian ini.
2. Kegagalan atau tidak dilakukannya kewajiban salah satu Pihak atau Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini bukanlah merupakan suatu pelanggaran terhadap Perjanjian ini, apabila dan selama hal ini disebabkan oleh (Force Majeure).
3. Dalam hal terjadi Force Majeure sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 (dua) pasal ini sehingga memengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami keadaan Force Majeure berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis secara tertulis/faksimili/e-mail kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (Tujuh) hari kerja terhitung sejak terjadinya Force Majeure tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Pihak yang terkena dampak oleh Force Majeure harus mengambil langkah-langkah wajar agar dapat melanjutkan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dalam waktu yang sesingkat mungkin dan akan tetap

memastikan pihak lainnya mendapatkan informasi lengkap mengenai rencananya untuk mengatasi dan/atau meminimalkan Force Majeure.

PASAL 15

KETENTUAN TAMBAHAN DAN PERUBAHAN

1. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian ini, demikian juga perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan yang dianggap perlu dilakukan terhadap isi Perjanjian ini dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak yang merupakan Addendum Perjanjian dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini;
2. Apabila selama berlakunya Perjanjian ini terdapat pasal yang karena hukum menjadi tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia, selanjutnya dimengerti dan disetujui oleh Para Pihak bahwa pasal yang tidak sah, tidak dapat dilaksanakan atau pasal yang bertentangan dengan ketentuan perundangan tersebut tidak mengakibatkan berakhirnya Perjanjian ini secara keseluruhan dan karenanya pasal-pasal yang lain masih tetap berlaku dan mengikat Para Pihak;
3. Segala ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku serta mengikat bagi masing-masing pihak yang menandatangani, pengganti-penggantinya, penerus dan/atau mereka yang ditunjuk oleh Para Pihak;
4. Perjanjian ini beserta seluruh lampiran-lampirannya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan suatu kesatuan dari perjanjian ini dan merupakan pemahaman antara Para Pihak sehubungan dengan pokok Perjanjian. Oleh karena itu Para Pihak mengesampingkan setiap dan semua pengertian, negosiasi-negosiasi, surat-menyurat atau perjanjian (baik lisan atau tertulis) sebelumnya diantara Para Pihak yang tidak tergabung dalam Perjanjian ini;
5. Judul pasal-pasal yang dicantumkan tidak akan ditafsirkan sebagai pembatasan terhadap maksud pokok isi pasal tersebut dan tidak akan digunakan dalam menafsirkan Perjanjian ini dan tidak akan digunakan dalam menafsirkan untuk tidak melaksanakan prestasi dalam Perjanjian ini;

Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam dua rangkap bermaterai cukup, dipegang oleh Setiap Pihak yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Jakarta, 1 Mei 2026

Pihak Pertama,
PT DISA PRIMA PRIMA
RS DHARMA HUSADA PROBOLINGGO

dr. Sefrina Trisadi, Sp.DVE
Direktur

Pihak Kedua,
PT ASURANSI MULTI ARTHA GUNA, Tbk
(ASURANSI MAG)

Muhammad Reza Putra S. IP
Kepala Divisi Asuransi Kesehatan/GHS